



Protocolo Resolutivo: Sífilis Congênita e HIV

Um Guia Clínico Interativo para o Manejo
de Recém-Nascidos Expostos

Objetivos da Missão Clínica



Identificar e Estratificar

Reconhecer critérios exatos de risco para exposição à sífilis congênita e ao HIV no momento do parto.



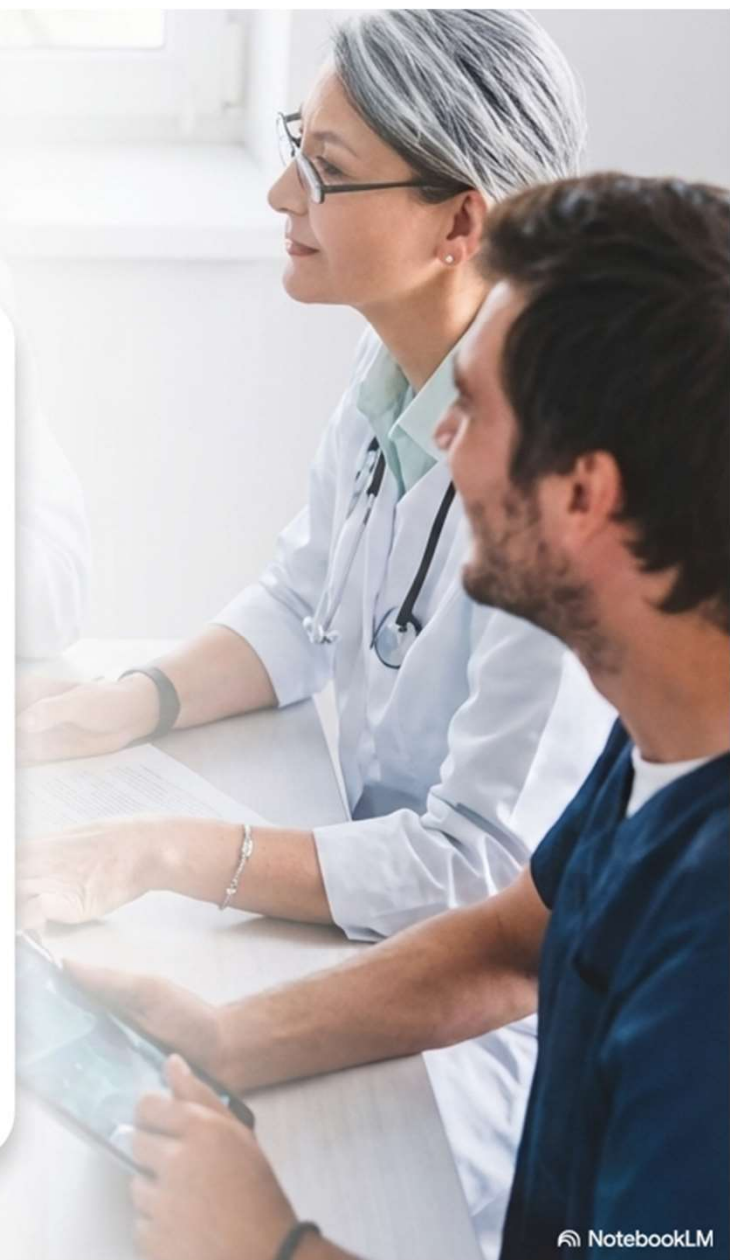
Investigar com Precisão

Solicitar exames laboratoriais e de imagem (sangue, líquido, raio-x) seguindo estritamente o fluxo protocolar.



Manejar e Tratar

Indicar a terapêutica correta (Penicilina vs. Profilaxia ARV) e estruturar o acompanhamento ambulatorial até a alta.



O Desafio Clínico (Briefing da Admissão)

Gestante (28 anos, G2P1A0)

- **Status HIV:** Vive com HIV há 3 anos. Uso regular de TARV. Carga viral indetectável.
- **Pré-natal:** 9 consultas. Exames prévios para sífilis todos negativos.



O Problema: Na admissão para o parto, o Teste Rápido para Sífilis foi POSITIVO. VDRL reagente (1:64).

Recém-Nascido (Momento Zero)

A termo (38 sem e 3 dias).

Peso: 3.250g | Estatura: 49,5 cm | PC: 38 cm.

Apgar 8/9. Assintomático, exame físico normal no primeiro momento.



Momento 1: Nascimento e Biossegurança

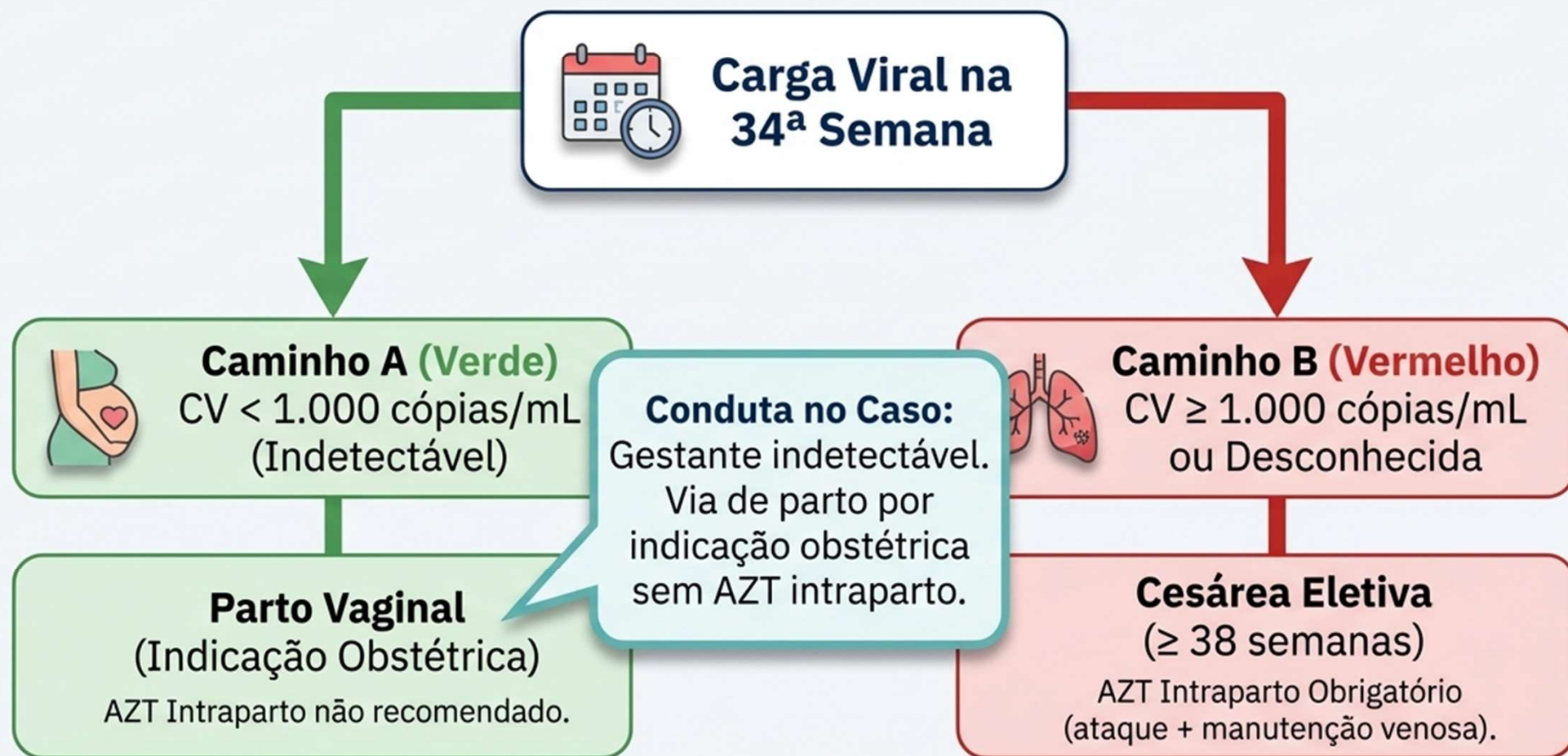
FAZER (Verde)

- ✓ Parto Empelicado (manter membranas íntegras na cesárea). 
- ✓ Clampeamento imediato do cordão umbilical. 
- ✓ Banho imediato do RN (em água corrente) e higienização de face. 

NÃO FAZER (Vermelho)

- ✗ NÃO realizar ordenha do cordão umbilical. 
- ✗ EVITAR: Amniotomia artificial, fórceps, vácuo-extrator e episiotomia. 
- ✗ EVITAR: Aspiração (fazer apenas se estritamente necessário e com cuidado rigoroso). 

Decisão da Via de Parto: A Carga Viral Dita a Regra



Desafio HIV: Estratificação de Risco do RN

Baixo Risco

CrITÉrios:



Mãe em TARV na gestação + CV
Indetectável no 3º trimestre +
Boa adesão.

Prescrição:



AZT (Zidovudina) solução oral por
28 dias.

Alto Risco

CrITÉrios:

Sem pré-natal **OU** sem TARV **OU**
diagnóstico no parto **OU** CV
Indetectável.

Prescrição:



Esquema Triplo (AZT + 3TC +
Raltegravir/Nevirapina) por 28 dias.

 O nosso RN é de
BAIXO RISCO

Desafio HIV: Conduta Imediata no Alojamento Conjunto

Pilar 1: Profilaxia e Exames

Iniciar AZT (Zidovudina) preferencialmente nas primeiras 4 horas de vida.

Coletar exames na maternidade: Hemograma, Função Hepática e a 1ª Carga Viral.



Pilar 2: A Regra de Ouro da Nutrição



Amamentação é **CONTRAINDICADA** no Brasil, mesmo com carga viral indetectável.

Proibido aleitamento cruzado ou leite pasteurizado domiciliar.

Pilar 3: Manejo Materno e Garantia

Inibição farmacológica da lactação (Cabergolina 1mg dose única pós-parto).

Direito ao fornecimento de **Fórmula Láctea Infantil** até os 6 meses.

A Reviravolta: O VDRL Materno Reagente

Inter: Avaliando o 'Filtro Materno' para Sífilis Congênita

Critérios de Tratamento Adequado da Mãe (TUDO deve ser SIM):

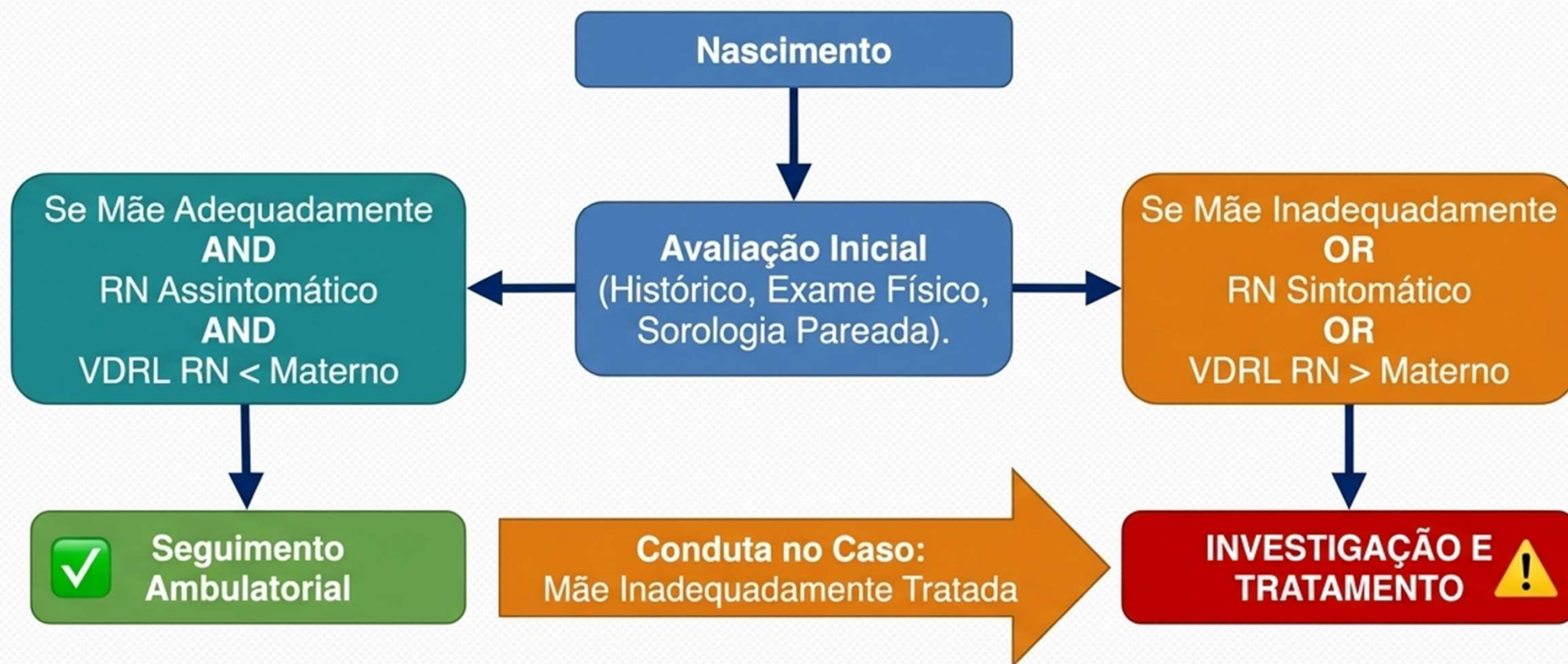
- ☐ 1. Medicamento: Benzilpenicilina Benzatina?
- ☐ 2. Cronologia: Início até 30 dias antes do parto?
- ☐ 3. Esquema: Dose correta para o estágio clínico?
- ☐ 4. Intervalo: Respeito ao intervalo entre doses?



Atenção! Diagnóstico materno feito apenas no parto. A mãe falhou nos critérios. Considera-se **MÃE INADEQUADAMENTE TRATADA**.

Desafio Sífilis: Triagem e Investigação Inicial

Regra de Ouro: NUNCA usar sangue do cordão umbilical (Risco de falso-reagente).



Desafio Sífilis: A Investigação Obrigatória Completa



Sangue Periférico

- Hemograma Completo (buscando anemia/plaquetopenia) e Teste Não Treponêmico (VDRL).



Imagem

- Raio-X de Ossos Longos (buscando osteocondrite/periostite).



Líquor (LCR)

- Punção Lombar para análise de células, proteínas e VDRL líquido.



Nota Importante

Testes Treponêmicos (rápidos) **NÃO** são indicados antes dos **18 meses** devido à passagem de anticorpos maternos (IgG).

Desafio Sífilis: O Fator Neurológico (LCR)

Qualquer alteração indica tratamento hospitalar obrigatório por 10 dias.

Critérios Diagnósticos no Líquor (Recém-Nascido / Pré-Termo):

VDRL Liquórico	REAGENTE (Diagnóstico Definitivo)
Células (Leucócitos)	> 25 células/mm ³
Proteínas	> 150 mg/dL



A neurosífilis ocorre em até 60% dos casos de Sífilis Congênita.

Desafio Sífilis: Protocolos Medicamentosos

A Supremacia da Penicilina (Não há relatos de resistência).



Cenário TUDO NORMAL

(Assintomático + Exames Normais + VDRL Negativo)

 Benzilpenicilina Benzatina
(Dose Única - 50.000 UI/kg IM)

Caveat: Se não houver garantia de seguimento, internar e tratar 10 dias.



Cenário ALTERADO (Sem Neurosífilis)

Penicilina Cristalina (EV) OU
Procaína (IM) por 10 dias.



Cenário ALTERADO (Com Neurosífilis)

Penicilina Cristalina (EV) por
10 dias (Exige Internação)

Conduta no Caso: Indicação de tratamento com **Penicilina Cristalina EV por 10 dias.**
Posterior alta hospitalar ou término com **Procaína IM** via UBS de referência.

Momento 3: Planejando a Alta (Seguimento HIV)



Cuidados Adicionais na Alta

- **Vacinação:** BCG e Hepatite B imediatas.
- **Profilaxia de Pneumocistose:** Iniciar SMX-TMP com 4 semanas de vida (manter até exclusão do HIV).

Critério de Alta do Serviço Especializado

Após 18 meses OU com dois exames de CV indetectáveis + sorologia negativa.

O Caminho da Cura (Seguimento **Sífilis**)

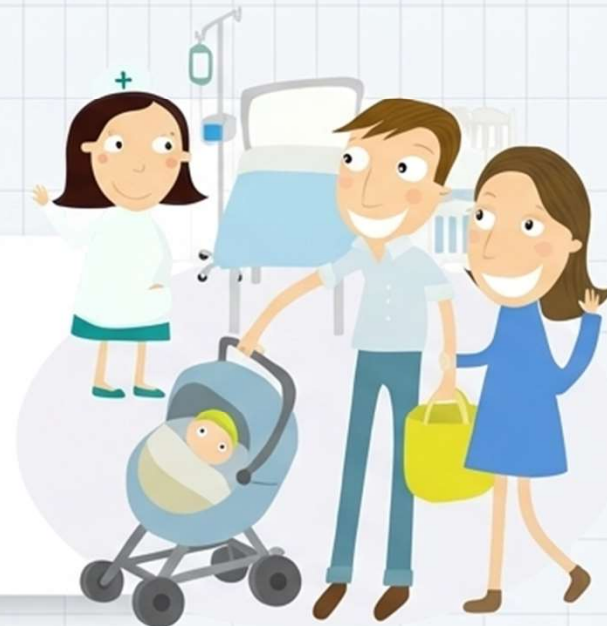


Consultas de Especialidades

Avaliação Oftalmológica e Audiológica semestral por 2 anos.

Critério de Alta Sorológica

- Dois testes não reagentes consecutivos. (Lembrete: Teste treponêmico apenas após 18 meses).



Erradicação e Checklist Final

Os 4 Pilares da Prevenção



Pré-Natal de Qualidade

Testagem trimestral



Tratamento do Parceiro

Evitar reinfecção



Vigilância Ativa

Notificação compulsória



Busca Ativa

Recuperar faltosos

“A sífilis congênita é uma doença totalmente prevenível. Cada caso é uma oportunidade perdida de cuidado.”

Referências: Sociedade Brasileira de Pediatria - Departamento Científico de Neonatologia (Setembro 2025).

Checklist de Autoavaliação Clínico

- ☒ Avaliei o status do filtro materno?
- ☐ Iniciei AZT oral no RN em até 4 horas?
- ☐ Inibi a lactação e garanti a fórmula infantil?
- ☐ Solicitei Investigação Completa (LCR, RX, HMG, VDRL) para Sífilis?
- ☐ Prescrevi Penicilina Cristalina EV (10 dias)?